

Naruszenie *oczekiwań*

Najskuteczniejsza interwencja w OCD — 60–90% pacjentów osiąga istotną redukcję. Nie habituacja: uczenie się, że katastrofa nie następuje.

CZAS: 30–90 min na sesję ekspozycji Sesje 4–5× tygodniowo przez 8–16 tygodni

ŹRÓDŁO: Foa i Kozak (1986); Abramowitz i wsp. (2009); Craske i wsp. (2014); NICE CG31

JAK UŻYWAĆ

Wybierz pozycję z **hierarchii ekspozycji** (start SUDS 30–50). Zapisz co *przewidujesz*. Doświadczaj bodźca **bez kompulsji**. Monitoruj SUDS co 5 min. Po: porównaj prognozę z rzeczywistością. Powtarzaj 3–10× aż SUDS ≤ 30. Mózg uczy się: „*bałem się katastrofy, a jej nie było*”.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Ekspozycja in vivo (łac. *in vivo* — „w warunkach rzeczywistych”) to **gradualna konfrontacja z realnym wyzwalaczem bez kompulsji**. Abramowitz i wsp. (2009, meta-analiza): **60–90% pacjentów** osiąga istotną redukcję objawów. Foa i Kozak (1986): mechanizm *emocjonalnego przetwarzania* — aktywacja sieci lęku + nowe informacje korygujące. Craske i wsp. (2014) zaktualizowali model: nie *habituacja* jest celem (przyzwyczajanie się), ale **naruszenie oczekiwań** (ang. *expectancy violation*). Mózg uczy się: „*myślałem, że będzie katastrofa — nie było jej*”. Każda ucieczka od wyzwalacza obniża lęk krótkoterminowo, ale **utrwała** cykl długoterminowo.

01 ? Dlaczego unikanie wzmacnia OCD

UNIKANIE / KOMPULSJA

Wyzwalacz → lęk → ucieczka/kompulsja → **krótka ulga**.

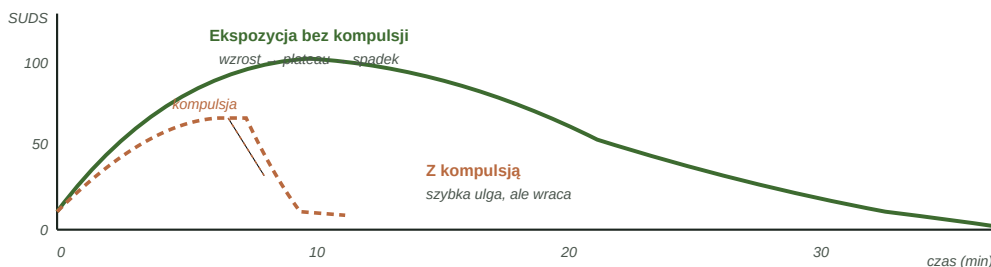
Mózg uczy się: „*lęk jest niebezpieczny, kompulsja go usuwa*”. Wzorzec utrwała się przez lata.

EKSPOZYCJA + RP

Wyzwalacz → lęk → **nic nie robię** → lęk opada sam (10–60 min).

Mózg uczy się: „*lęk nie jest niebezpieczny, opada sam — bez kompulsji*”. Wzorzec rozpada się.

02 ? Krzywa SUDS — co się dzieje podczas ekspozycji



Typowy wzorzec ekspozycji bez kompulsji: SUDS rośnie szybko (0–5 min), *plateau* wysokie (5–15 min), naturalny spadek (15–30+ min). Lęk **opada sam**, bez pomocy kompulsji. To *naruszenie oczekiwań* — mózg dostaje nowe dane.

03 Twoja sesja ekspozycji — protokół

POZYCJA Z HIERARCHII

— co robię konkretnie

GDZIE I JAK DŁUGO

— miejsce, czas trwania

CO PRZEWIDUJĘ, ŻE SIĘ STANIE

— jaka katastrofa

JAK BARDZO WIERZĘ W TĘ PROGNOZĘ

— 0–100%

CZAS (MIN)	SUDS	CO CZUJĘ / JAKIE MYŚLI
0 — start		
5		
10		
15		
20		
30 — koniec		

04 Po ekspozycji — naruszenie oczekiwań

CO NAPRAWDĘ SIĘ STAŁO

— porównaj z prognozą

CZEGO SIĘ NAUCZYŁEM/-AM

— konkretny wniosek dla mózgu

Powtarzaj tę samą ekspozycję 3–10× w ciągu kilku dni — aż SUDS spadnie do ≤ 30 .

Wariuj konteksty (Craske 2014) — różne miejsca, godziny, sposoby. To *generalizuje uczenie*.

Awansuj wyżej po opanowaniu poziomu. Hierarchia jest żywa — modyfikuj po każdym sukcesie.

Klucz: Craske i wsp. (2014) — przełomowa rewizja ERP: *celem nie jest habituacja* (przyzwyczajenie się do lęku w sesji), ale **naruszenie oczekiwań** w długoterminowym uczeniu. Mózg dostaje konkretne dane: „*myślałem, że będzie X, a stało się Y*”. Dlatego po ekspozycji **jasno formułuj**, co przewidywałeś i co się naprawdę stało. Bez tego porównania ekspozycja jest *terapią cierpienia*, nie uczeniem. ERP wymaga **doświadczonego terapeuty** — szczególnie w pierwszych sesjach. Samodzielne ERP możliwe po opanowaniu protokołu.